

REACCIONES TRANSFUSIONALES

Yolanda Martínez Díez, M^a Soledad Sánchez Fernández, Teresa Arquero Portero, Pilar Llamas Sillero.

INTRODUCCIÓN

La transfusión no es una práctica exenta de riesgos. Ante toda sospecha de reacción transfusional se debe parar la infusión y comunicarlo al Servicio de Transfusión.

En general las reacciones transfusionales se agrupan en:

	INMUNOLÓGICAS	NO INMUNOLÓGICAS
Inmediatas	Hemolíticas, febriles no hemolíticas, alérgicas/anafilácticas, EAP no cardiogénico	Hemólisis física/química, contaminación bacteriana, metabólicas, sobrecarga de volumen.
Retardadas	Hemolíticas retardadas, aloinmunización, púrpura postransfusional, EICH asociada a transfusión.	Hemosiderosis, transmisión de enf. infecciosas (VHC, VHB, VIH, HTLV, CMV, bacterias, parásitos)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Reacciones febriles no hemolíticas

Muy frecuentes, con una incidencia del 1-2% (> en politransfundidos o multíparas). Aparecen generalmente en las dos horas posteriores. No son graves, y hay que recordar que puede ser el primer síntoma de otra reacción más severa. Es importante medir la temperatura antes de la transfusión, para evitar confundirla con hipertermia previa.

Si se sospecha otra causa subyacente que ocasione la fiebre, se deben extraer hemocultivos del paciente y del CS transfundido, que se debe devolver al Banco de Sangre para completar el estudio.

Tratamiento

Parar o disminuir la velocidad de infusión y dar **antitérmicos** (pe: paracetamol). Según la etiología que se sospeche, añadir otras medidas (pe: antibioterapia).

Sobrecarga hídrica:

Ocurre al transfundir mucho volumen o muy rápido, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. La clínica es superponible a la de cualquier insuficiencia cardíaca.

Tratamiento

Parar la transfusión e iniciar **diuréticos y oxígeno**. Los pacientes con anemia crónica pueden presentar signos de IC previos a la infusión, por lo que, cada unidad debe ser administrada lentamente, o fraccionada, seguida de 20-40mg de furosemida, y con vigilancia estrecha. Restringir la infusión a 1 CH cada 12 horas reduce el riesgo de disfunción ventricular izquierda.

Reacciones hemolíticas

Son la causa de muerte evitable más frecuente. La hemólisis no inmune ocurre por calentamiento o velocidad inadecuados o por infusión en la misma vía que otros fármacos; suelen ser leves y su manejo es sencillo. La hemólisis inmune se caracteriza por fiebre, dolor lumbar o torácico, disnea, ↓ PA, ↑ FC, coluria, CID...Puede ser mortal.

Tratamiento

Parar la transfusión. En las severas, iniciar **sueroterapia** (diuresis > 100mL/h), manitol y diuréticos. Considerar aminos vasoactivos, si persiste hipotenso, y diálisis si fracaso renal agudo. Pueden precisar UCI.

Reacciones alérgicas

La mayoría son reacciones alérgicas leves, que se ven como una urticaria y/o prurito a los pocos minutos de iniciar el procedimiento. La anafilaxia es rara (más frecuente con PFC) pero muy grave. Ocurre de forma precoz durante la transfusión. Se manifiesta con disnea, dolor torácico o abdominal y náuseas. Pueden aparecer hipotensión, broncoespasmo, edema periorbitario y laríngeo, vómitos, eritema/urticaria, etc.

Tratamiento

Parar la transfusión. En casos leves ceden con antihistamínico, para la anafilaxia hay que iniciar **corticoides +/- adrenalina**.

Edema agudo de pulmón no cardiogénico (TRALI)

Es raro, pero muy grave. Sospechar en pacientes que comienzan con dificultad respiratoria y tos no productiva en las 2-8h posteriores a la transfusión y desarrollan un EAP no cardiogénico. Puede cursar con fiebre o neutropenia. Requiere una **radiografía tórax** (compatible con SDRA).

Tratamiento

Igual que el SDRA. Evitar el uso de diuréticos en estos pacientes. Si es posible, ingreso en UCI.

Contaminación bacteriana / sepsis

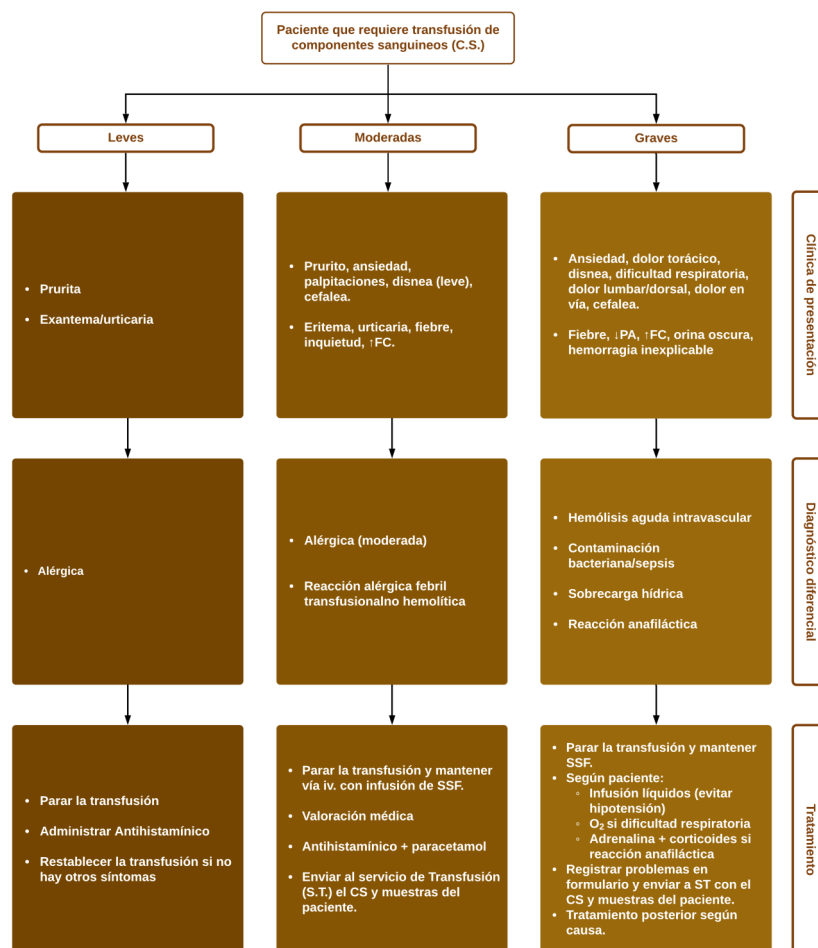
Tanto por bacterias Gram + como Gram -. Es muy rara (más frecuente con plaquetas). Se presenta de forma similar a las reacciones hemolíticas o anafilácticas.

Tratamiento

Soporte e inicio de **antibioterapia** de amplio espectro. No olvidar **HC y cultivo del CS**. Para su prevención se deben inspeccionar los CS antes de transfundir y no prolongar la infusión más de lo necesario.

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- La transfusión de hemocomponentes no es una práctica exenta de **riesgos**. Toda reacción transfusional debe **ser comunicada** al Servicio de Transfusión, quienes avisarán a los sistemas de hemovigilancia.
- Confirmar la identidad del paciente, tomar **constantes** antes de transfundir y respetar los **tiempos** de infusión.
- Ante toda sospecha de reacción transfusional, y hasta que se aclare, se debe **parar la transfusión**. Aunque las reacciones transfusionales **graves son infrecuentes**, dada su severidad debemos conocerlas.



BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmático*s. 5ªedición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ªEd. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ªEd. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensive. 2013; 37(4): 259-83.
- BCSH Blood Transfusion Task Force. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions*. Br J Haematol. 2012; 159(2):143-53.
- Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. Blood. 2009; 113(15): 3406.
- Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, Tinmouth AT, Marques MB, Fung MK, et al, Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB. Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012; 157(1):.49
- Skeate RC, Eastlund T. Distinguishing between transfusion related acute lung injury and transfusion associated circulatory overload. Curr Opin Hematol. 2007; 14(6):682-87.